

Masterclass Clínico: Integración en Gastroenterología, Hepatología y Cirugía Vascular

Guía de Estudio de Alto Rendimiento | Fisiopatología, Diagnóstico y Manejo Quirúrgico

Producido en exclusiva por **BADBEAR.MED**



Facebook |



Instagram |



YouTube |



Rutube |



OnlyFans |

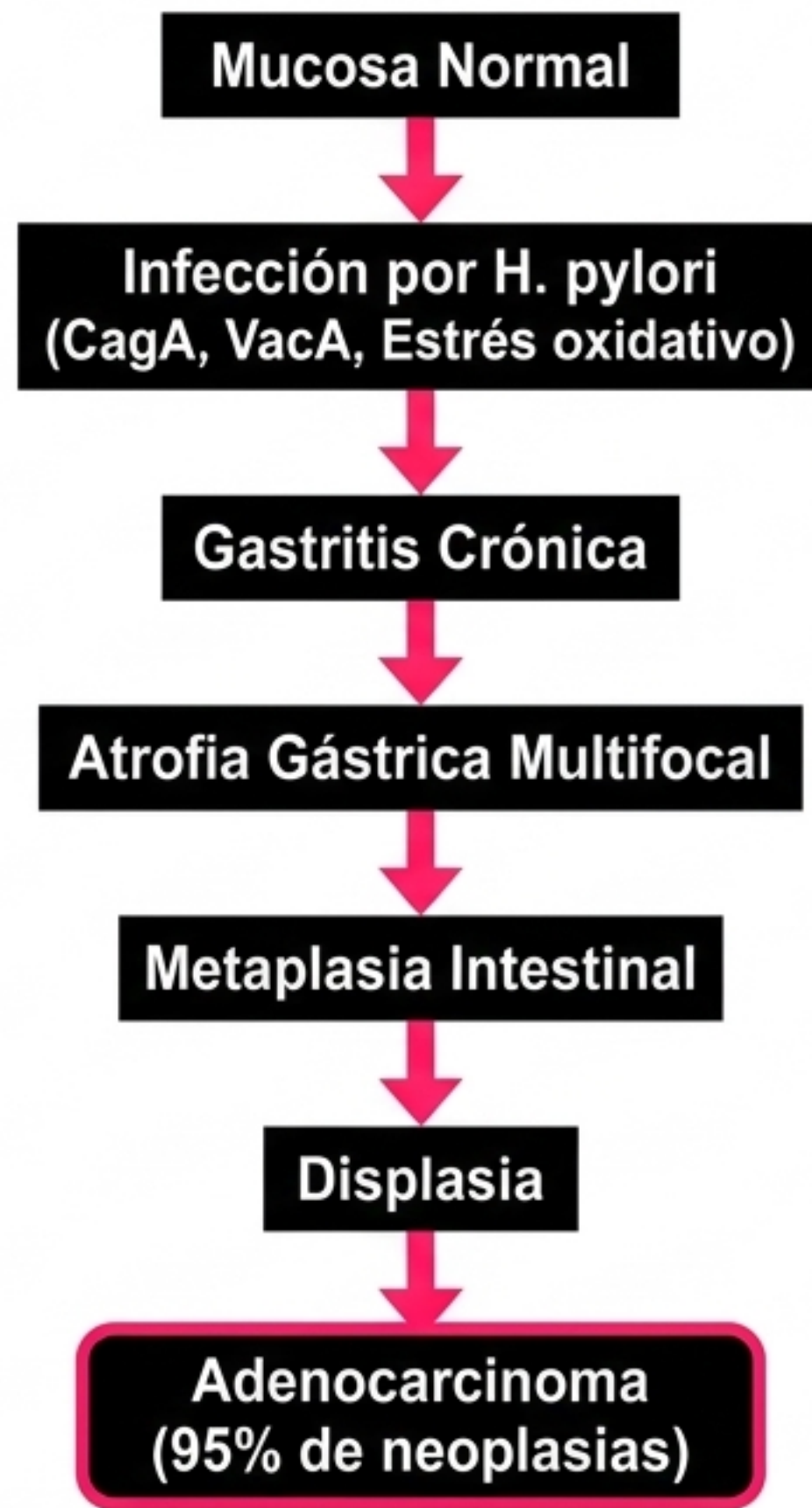
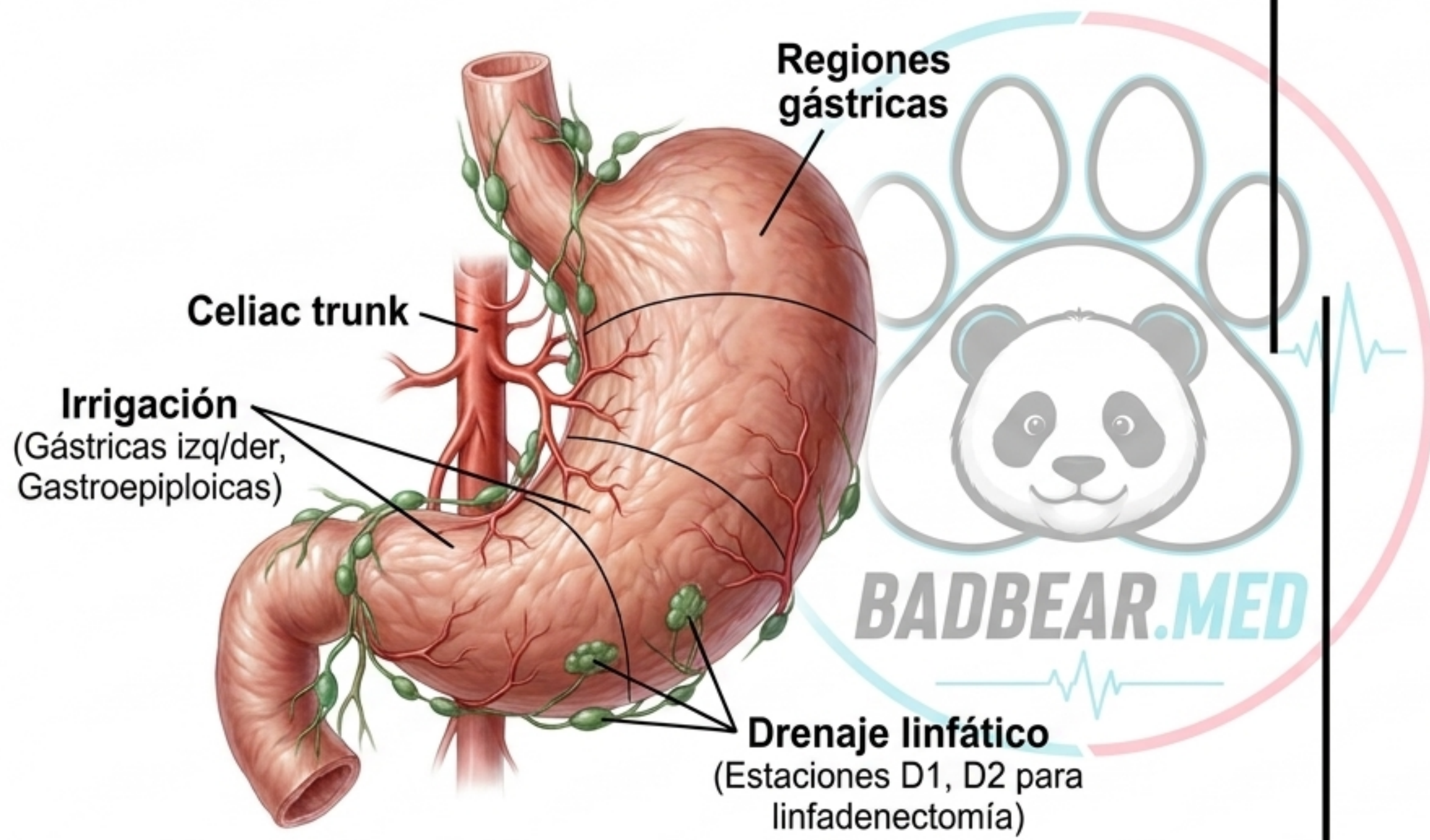


Telegram |



TikTok

Cáncer Gástrico: Anatomía y la Cascada de Correa



BADBEAR.MED



BADBEAR.MED



BADBEAR.MED

RUTUTUBE.MED



ONLYFANS



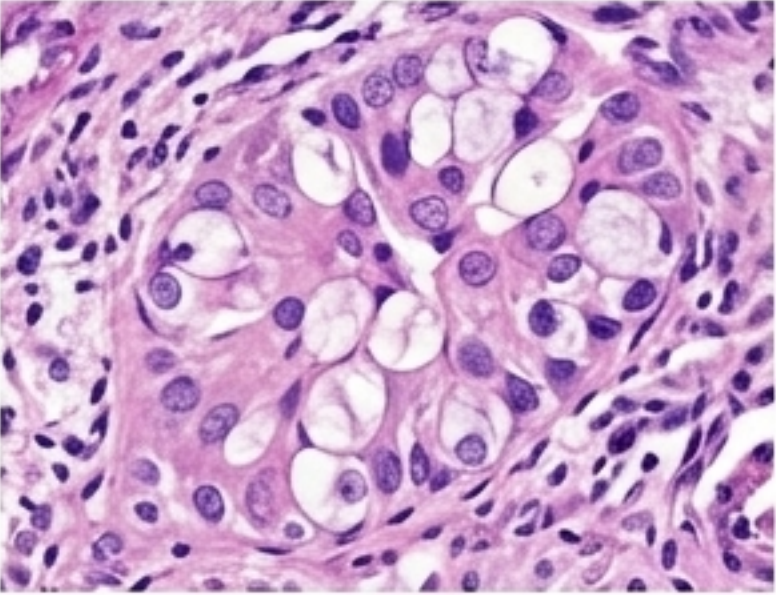
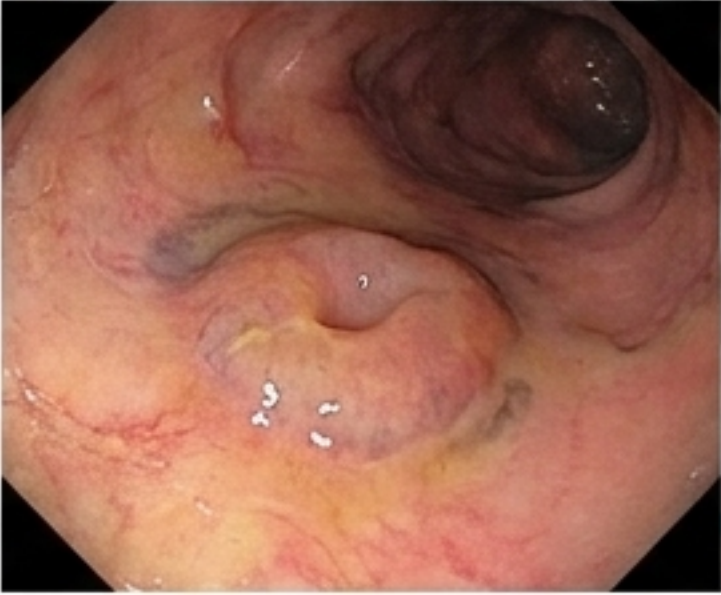
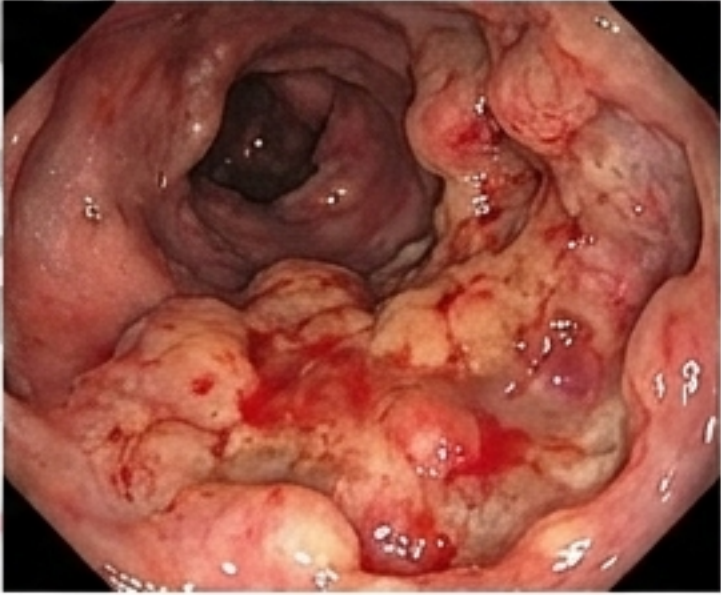
TELEGRAM



BADBEAR.MED

Gemini Notebook

Sistemas de Clasificación del Cáncer Gástrico

Lauren (Histología)	Japonesa (Temprano)	Bormann (Avanzado)	TNM (Estadificación)
Intestinal (Cohesivo, glandular) vs. Difuso (Células en anillo de sello, pobremente cohesivo). 	Limitado a mucosa/submucosa. 01 (Protruyente), 02 (Superficial - elevado/plano/deprimido), 03 (Excavado). 	I (Polipoide), II (Ulcerado delimitado), III (Úlcero-infiltrativo), IV (Infiltrativo difuso/ Linitis plástica). 	T (Profundidad en pared), N (Ganglios linfáticos), M (Metástasis).



BADBEAR.MED



BADBEAR.MED



BADBEAR.MED

RUTUTUBE.MED



ONLYFANS



TELEGRAM



BADBEAR.MED

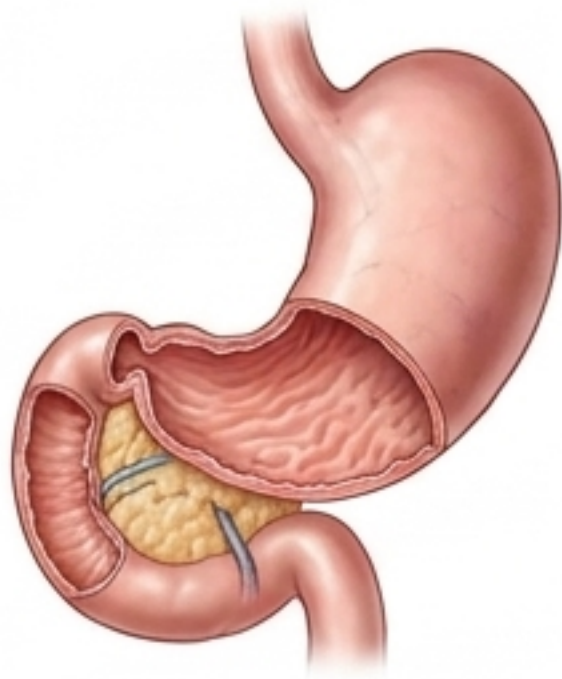
Gemini Notebook

Algoritmo de Manejo Quirúrgico y Reconstrucción

Enfermedad Localizada

Gastrectomía (Distal para 1/3 inferior, Total para proximal/extenso)
+
Linfadenectomía (D1 perigástricos, D2 ramas tronco celíaco)
-> Márgenes R0 (ideales).

Neoadyuvancia: Uso de esquema FLOT (Docetaxel, Oxaliplatino, Leucovorina, 5-FU) en enfermedad localmente avanzada.



Billroth I (Gástrico-Duodenal)



Billroth II (Gástrico-Yeyunal)



Y de Roux (Esófago-Yeyunal)



BADBEAR.MED



BADBEAR.MED



BADBEAR.MED



ONLYFANS



BADBEAR.MED

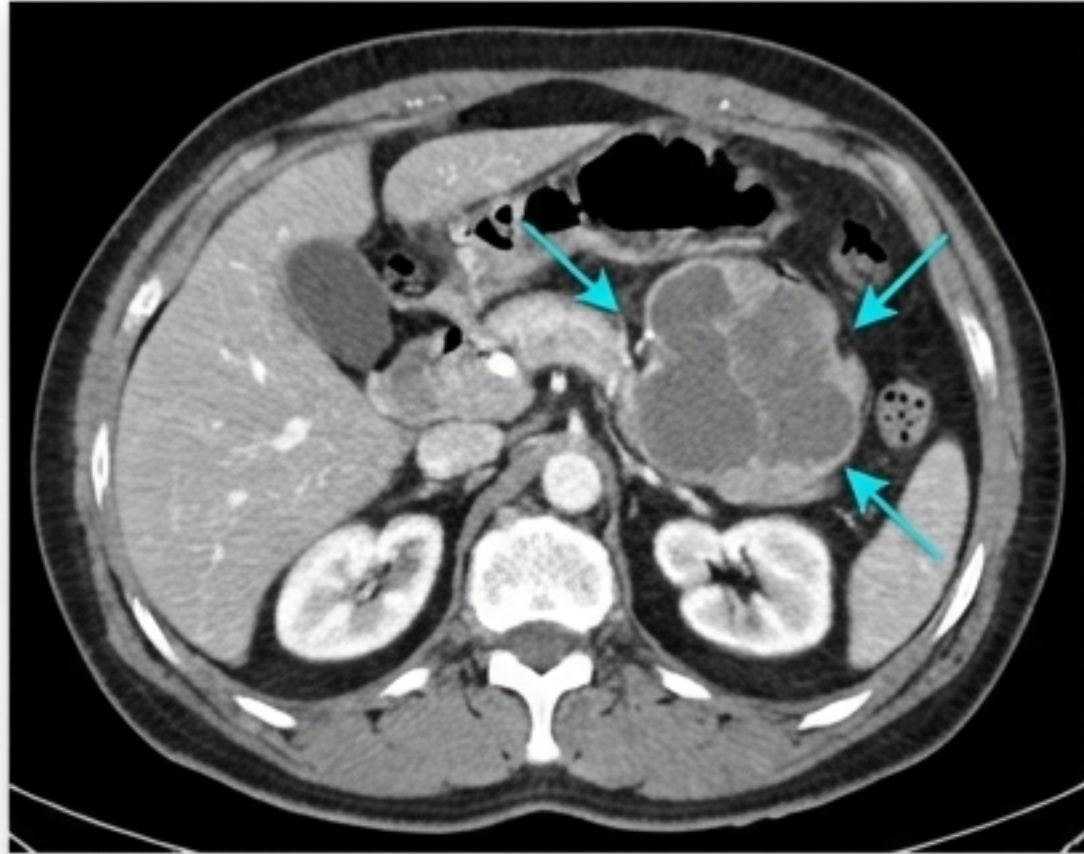


BADBEAR.MED

Gemini Notebook

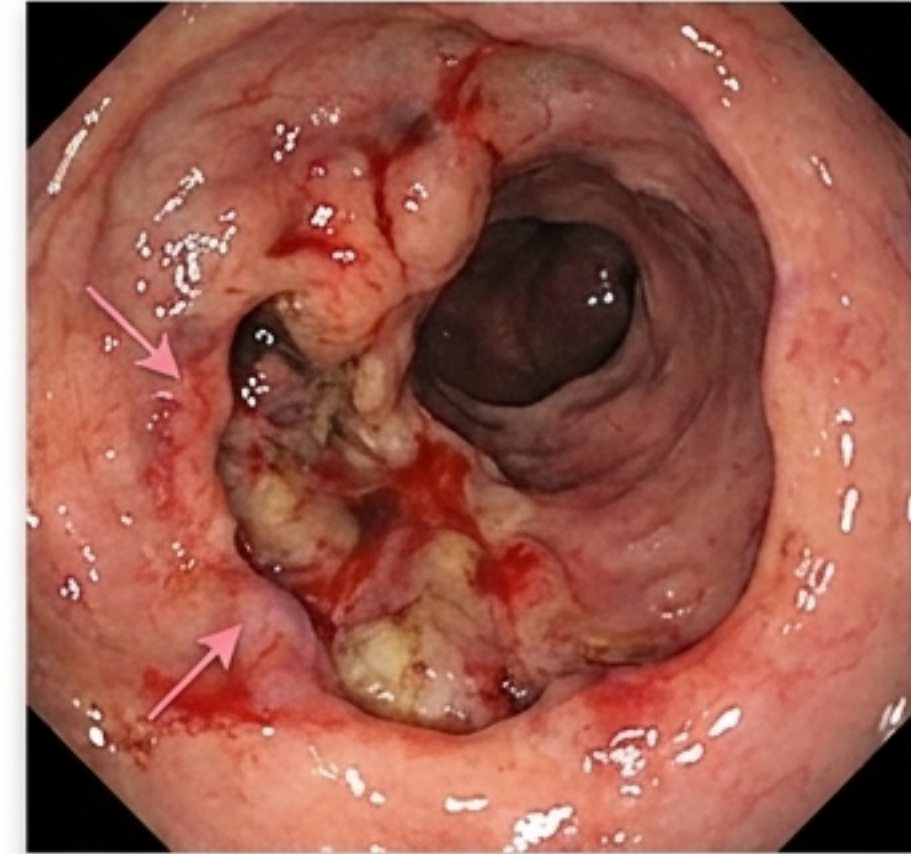
Casos Clínicos: Cáncer Temprano vs. Localmente Avanzado

Paciente 74 años (Temprano)



Presentación incidental (pérdida de peso, anemia).
Endoscopia: Lesión polipoidea gigante (7.2 cm) en cuerpo/antro.
Estadificación: T1 N0 M0 (Incipiente).
Cirugía: Gastrectomía Total + D2 + Y de Roux.
Curativo.

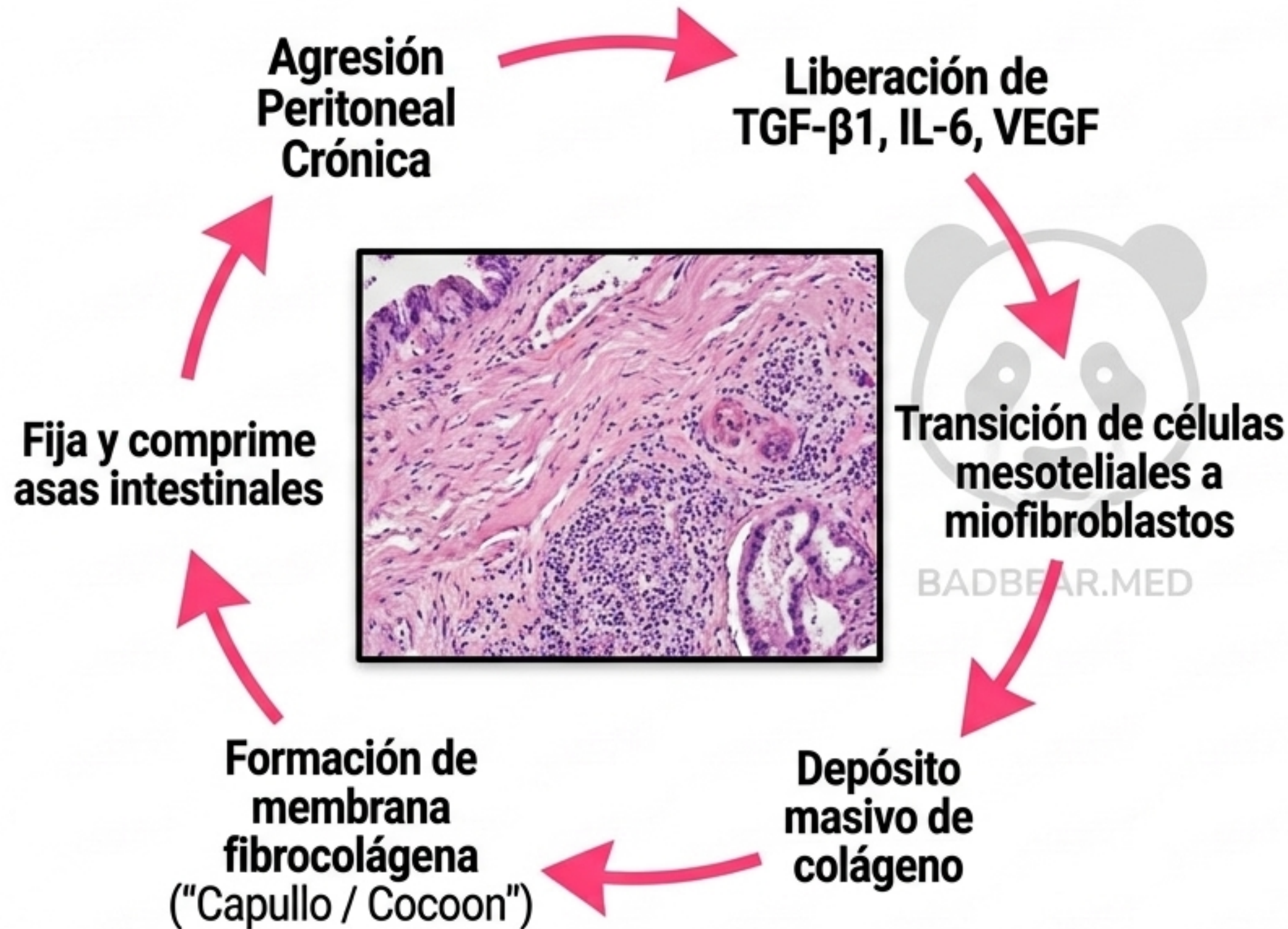
Paciente 43 años (Localmente Avanzado)



Clínica de anorexia (7kg en 2 meses).
Endoscopia: Lesión ulcerada circunferencial en antro distal.
Estadificación: T2 N+ M0 (Avanzado local).
Cirugía: Quimioterapia Neoadyuvante (FLOT) x4 ciclos -> Gastrectomía Subtotal + D2.



Peritonitis Esclerosante Encapsulante (PEE): Fisiopatología

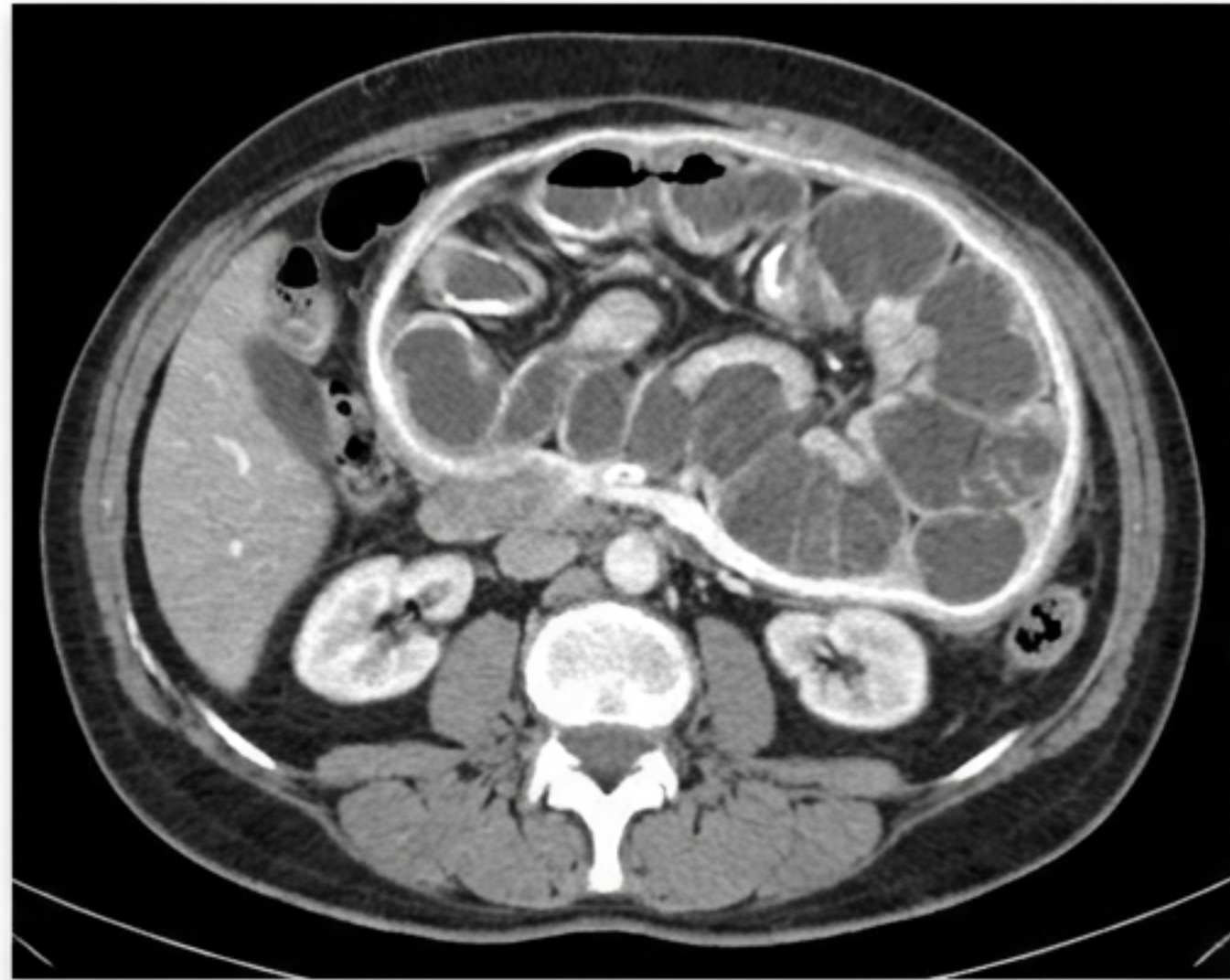


Etiología

- **Primaria** (Idiopática, hombres jóvenes, trópicos)
- **Secundaria** (Diálisis peritoneal prolongada, TB, cirugía previa).



PEE: Diagnóstico Tomográfico y Manejo



Tomografía (CT): Signo del 'Capullo Abdominal' (Asas de intestino delgado agrupadas y dilatadas, contenidas en una membrana engrosada tipo saco).

Clínica: Obstrucción intestinal recurrente (57.9%), dolor abdominal intermitente. Requiere alta sospecha clínica.

Manejo (Primaria)

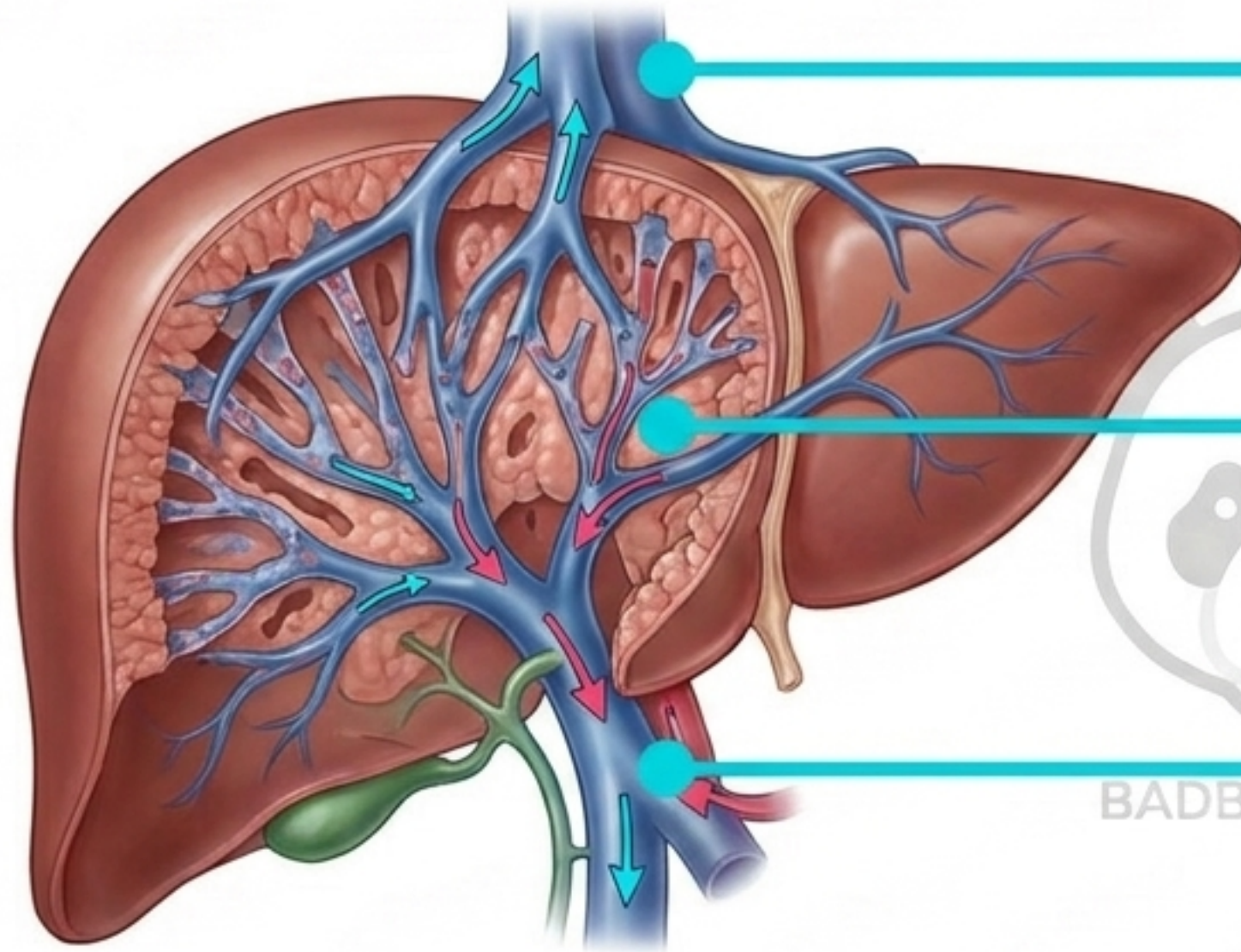
Quirúrgico. Liberación de asas, excisión de membrana (adhesiolisis).
Mortalidad: 3.6%.

Manejo (Secundaria)

Tratar causa subyacente (ej. detener diálisis), corticoides/tamoxifeno, soporte nutricional.
Cirugía solo en complicaciones.
Mortalidad: 45-82%.



Hipertensión Portal: Hemodinamia y Clasificación Anatómica



Post-hepática:

Síndrome de Budd-Chiari,
Falla cardíaca derecha.

Intra-hepática:

Presinusoidal (Esquistosomiasis),
Sinusoidal (Cirrosis),
Postsinusoidal (Enf. venoclusiva).

Pre-hepática: Trombosis
de vena porta (GPVH normal).

Fisiopatología: Ley de Ohm ($\Delta P = Q \times R$).
Aumento de resistencia vascular interhepática
o flujo esplácnico.

Gradiente de Presión Venosa Hepática (GPVH):

Normal 1-5 mmHg.

Clínica significativa ≥ 10 mmHg.

Riesgo de sangrado ≥ 12 mmHg.



BADBEAR.MED



Facebook



Instagram



YouTube



Rutube



OnlyFans



Telegram



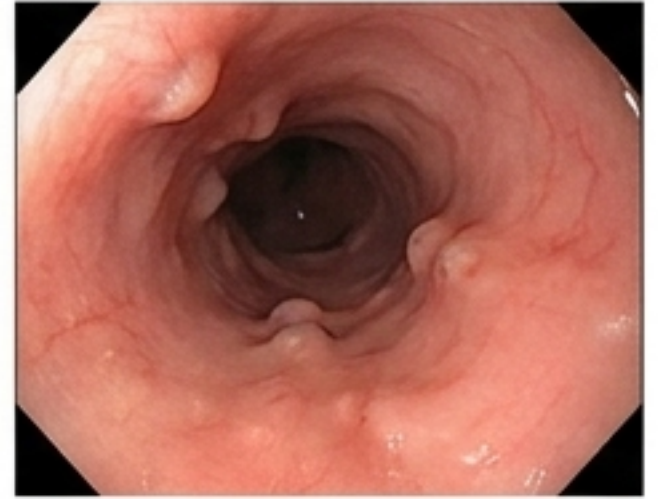
Badbear

Gemini Notebook

Enfermedad Vascular Portosinusoidal (PSVD): La Paradoja Clínica

Caso Clínico (Mujer 54 años):

Hallazgo incidental de várices esofágicas Grado I.
Función y morfología hepática normales.



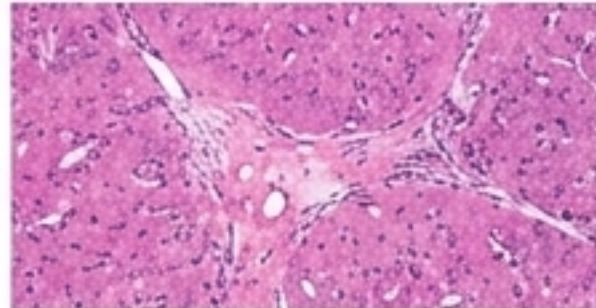
El Problema Hemodinámico:

GPVH normal (4 mmHg). ¿Por qué? El GPVH mide presión postsinusoidal. En PSVD, la resistencia es **presinusoidal**, **subestimando** la presión portal real.

Diagnóstico (Biopsia Transyugular):

Obligatoria para descartar cirrosis.

Hallazgo **clave**: Fibrosis septal incompleta sin
nódulos cirróticos.



Tratamiento:

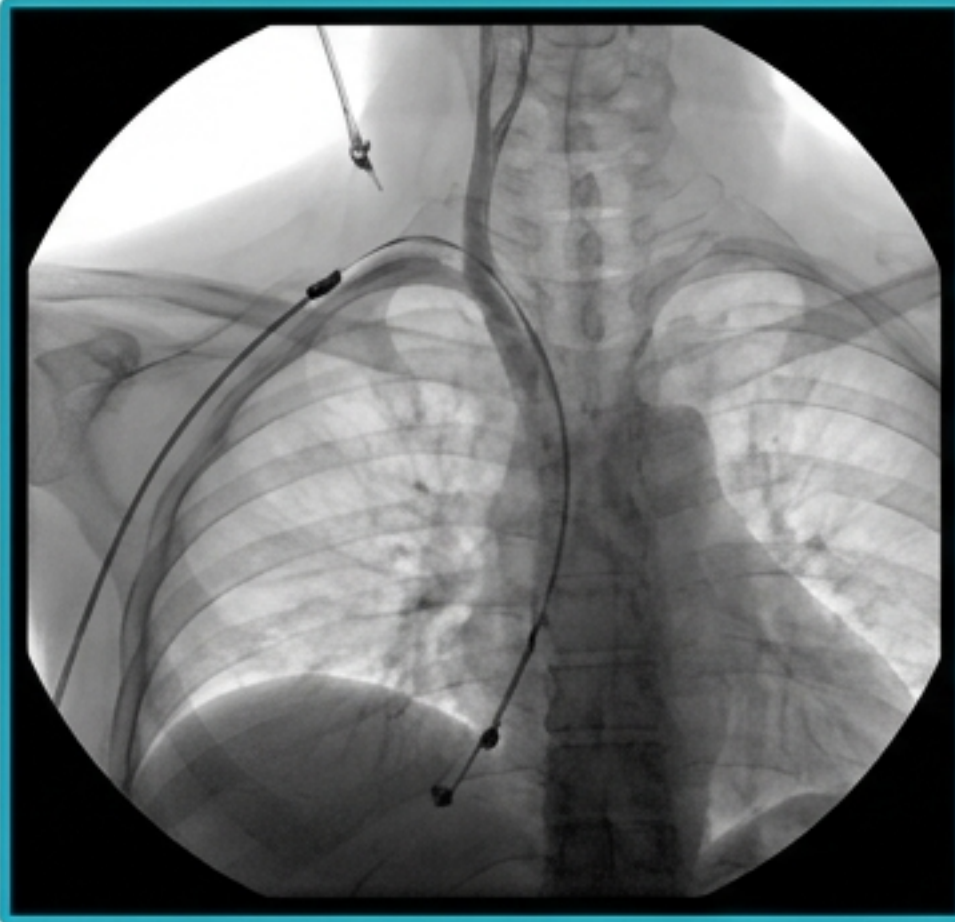
Similar a cirrosis
(Carvedilol 12.5 mg para
profilaxis de sangrado).
Pronóstico benigno.



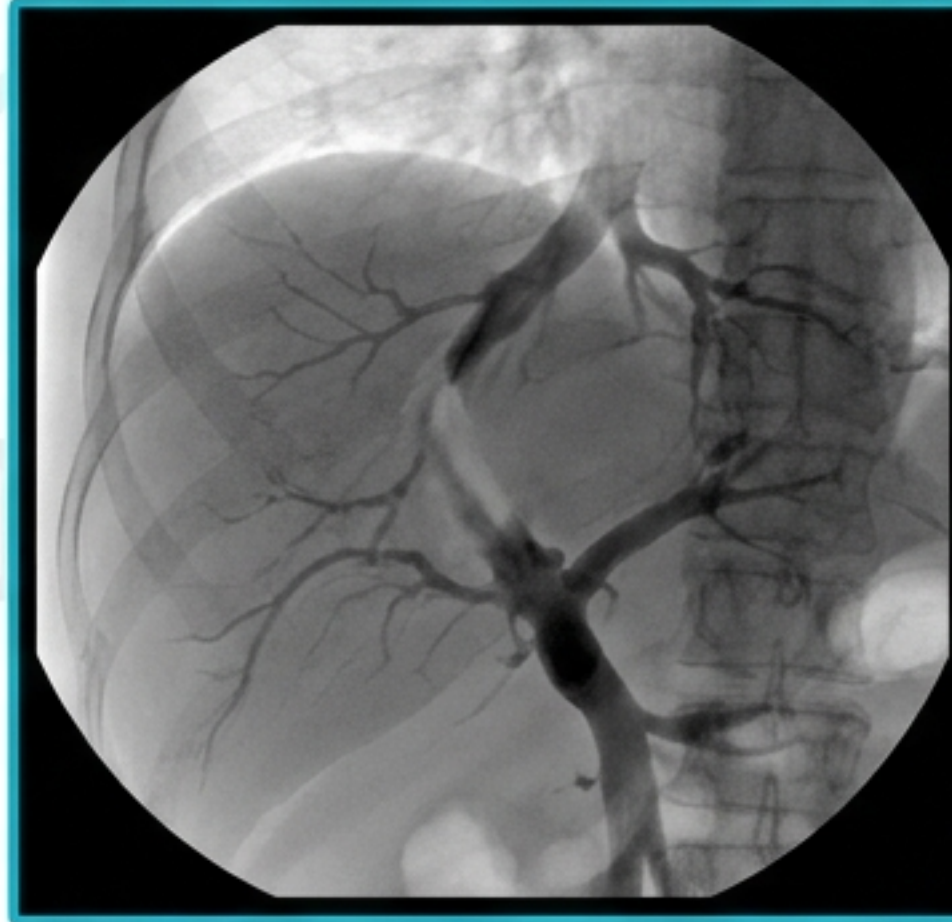
Manejo Intervencionista: Derivación Portosistémica (TIPS)

Indicación: Sangrado variceal refractario o ascitis intratable.

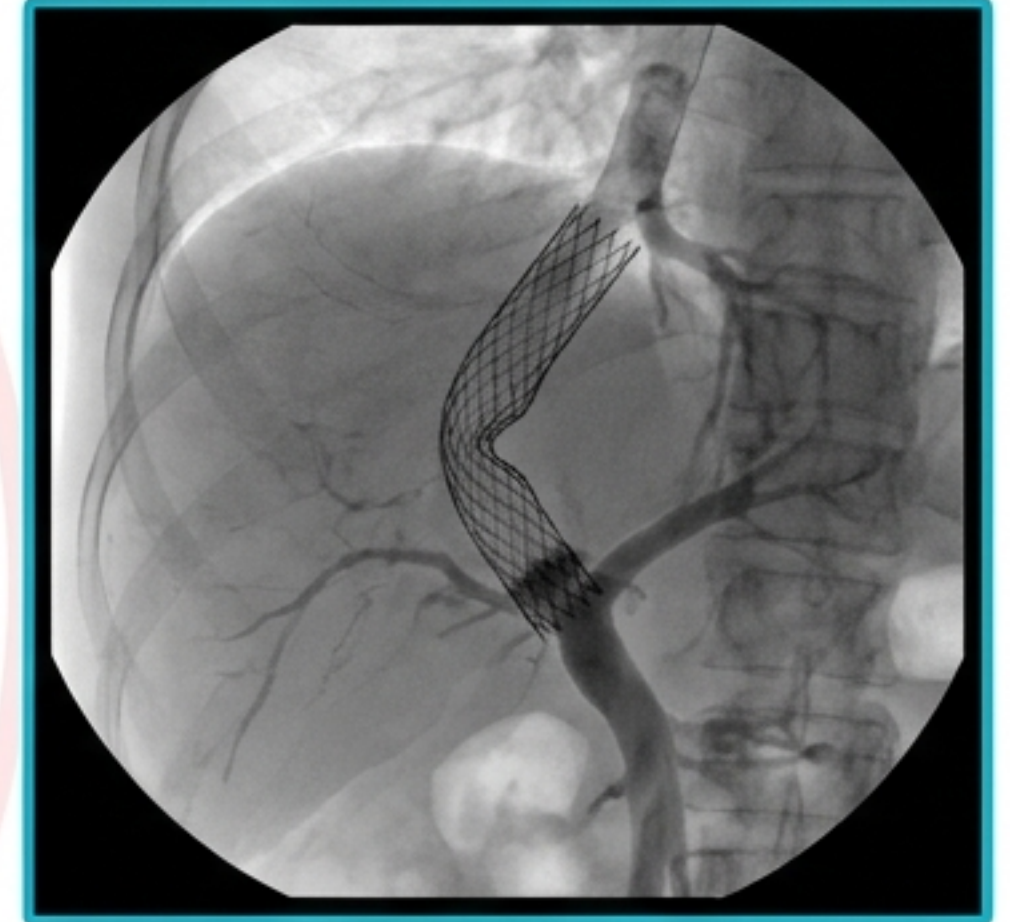
Mecanismo: Transforma un sistema de alta resistencia en un circuito de baja presión.



1. Acceso por vena yugular.



2. Creación de un túnel intrahepático conectando la vena hepática con la vena porta.



3. Colocación de un stent (endoprótesis) para mantener la permeabilidad.

Resultado: Desvía el flujo esplácnico directo a la circulación sistémica, colapsando la red colateral gastroesofágica.



Badbear.med



@badbear.med



Badbear.med



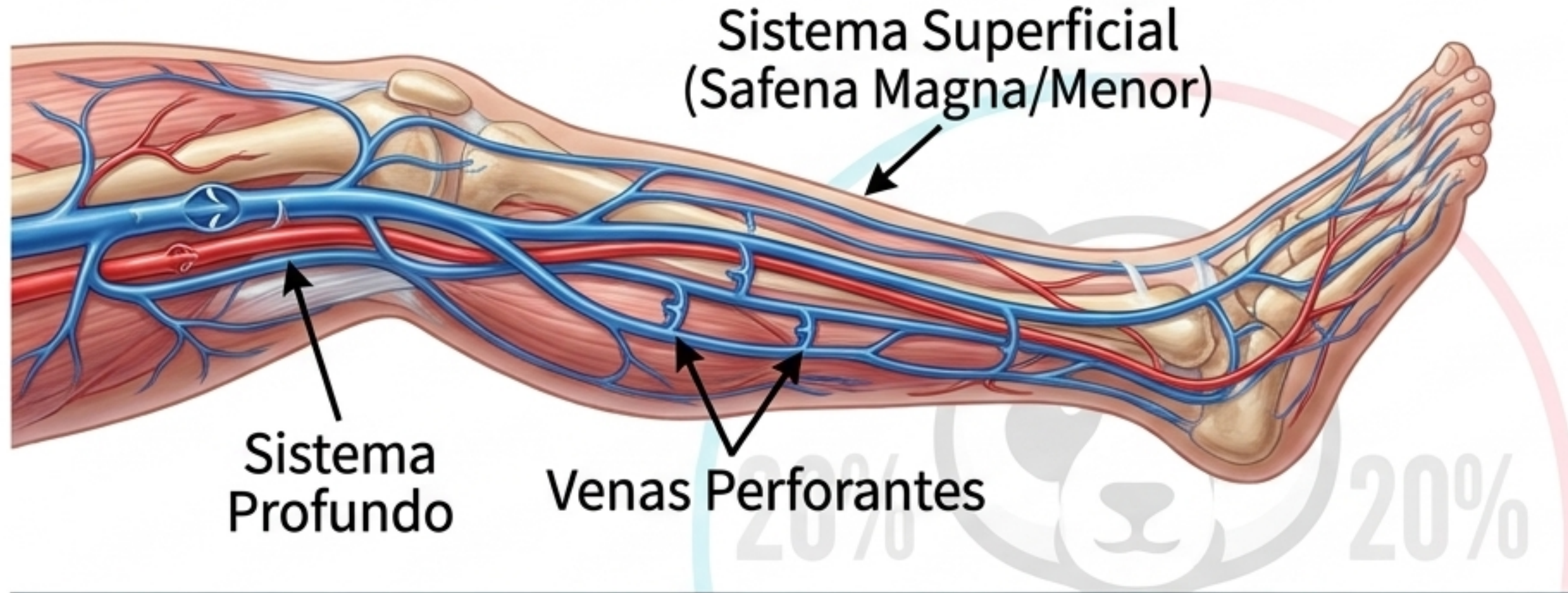
OnlyFans



TikTok

Gemini Notebook

Insuficiencia Venosa Crónica y Clasificación CEAP



Fisiopatología:

Incompetencia valvular u obstrucción → Flujo retrógrado → Hipertensión venosa (hidrostática y dinámica).

C (Clínica): C0 (Sin signos), C1 (Telangiectasias), C2 (Várices), C3 (Edema), C4 (Cambios cutáneos), C5 (Úlcera cicatrizada), C6 (Úlcera activa).

E (Etiología): Congénita, Primaria, Secundaria.

A (Anatomía): Superficial, Profundo, Perforante.

P (Fisiopatología): Reflujo, Obstrucción.



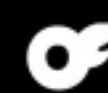
Badbear.med



@badbear.med



Badbear.med



OnlyFans



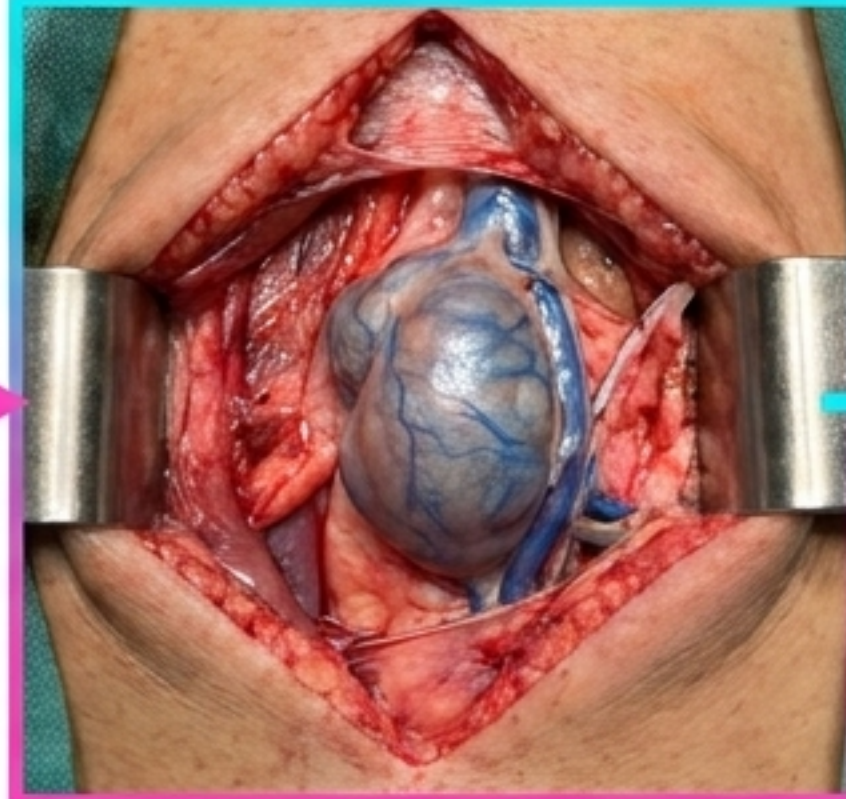
TikTok

Gemini Notebook

Caso Quirúrgico: Aneurisma de Safena Magna

El Error Diagnóstico (Varón 39 años):

Masa inguinal izquierda blanda, reductible, aumenta con Valsalva. Mal diagnosticado y operado hace 10 años como "hernia inguinal" (sin saco hallado).



El Diagnóstico Real:

Desarrollo de várices. Eco-Doppler revela aneurisma de safena magna (5x2 cm) a 2 cm de la unión safenofemoral con reflujo severo.

Cirugía Abierta Clásica:

1. **Crossectomía** (Ligadura y sección del cayado).
2. **Fleboextracción** (Stripping) con fleboextractor.
3. **Resección** de aneurisma y avulsión de tributarias.

20%

BADBEAR.MED



BADBEAR.MED



Badbear.med



@badbear.med



Badbear.med



Badbear.med



Badbear.med



Badbear.med



Badbear.med

Gemini Notebook

Cirugía Robótica en Tracto Digestivo: Costo vs. Beneficio

Tecnología: Visión 3D, instrumentos articulados, ergonomía vs. Laparoscopia (2D, rígida).

Desventaja principal: Costo operativo elevado y tiempo quirúrgico prolongado.



Matriz de Utilidad por Órgano

Esófago/Estómago: Excelente para disección fina (nervio laríngeo) y reconstrucción intracorpórea. Supervivencia oncológica igual a laparoscopia.

Páncreas: Ideal para Pancreatoduodenectomía (anastomosis complejas). Reduce conversión a cirugía abierta. Fístula pancreática sigue siendo el riesgo principal.

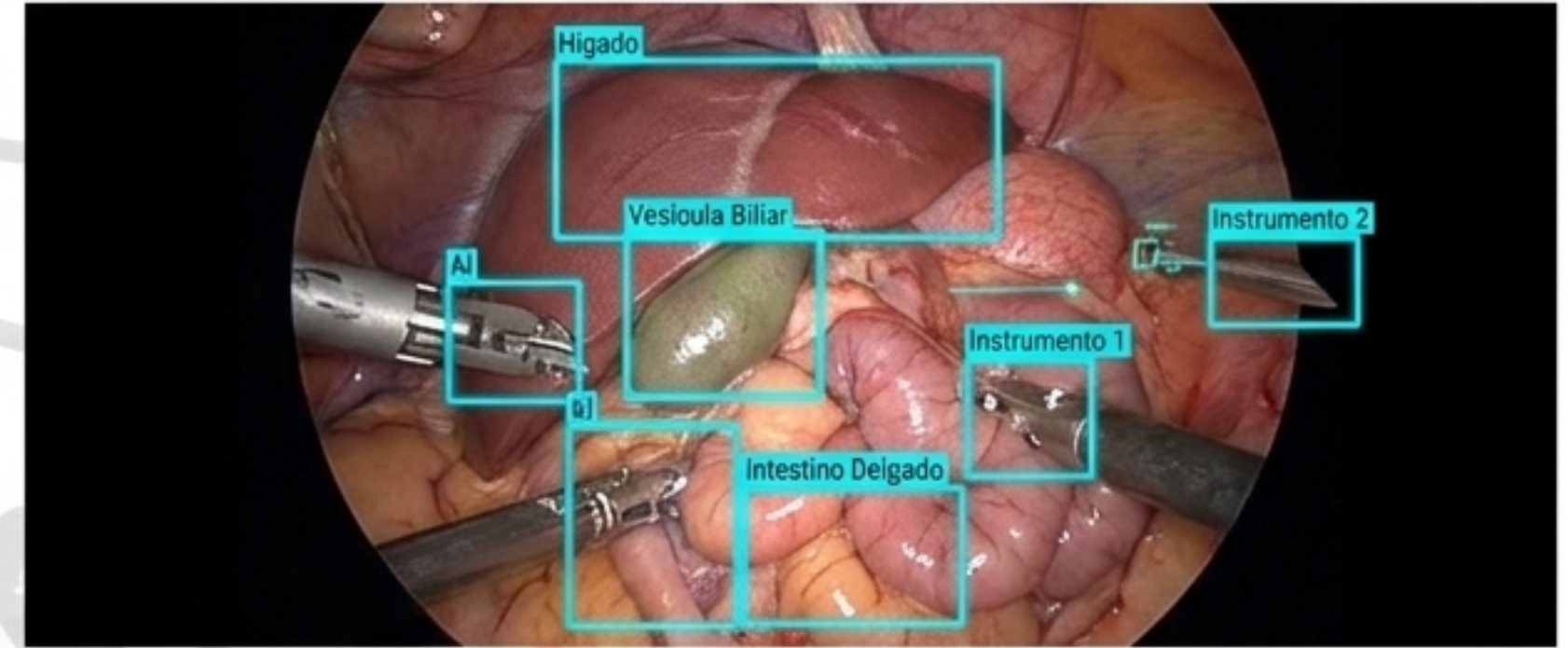
Colorrectal: Superioridad en pelvis profunda estrecha (preservación nerviosa, urinaria, sexual).

Conclusión: Costo-efectiva principalmente en centros de alto volumen y procedimientos de alta complejidad anatómica.



El Futuro: Inteligencia Artificial y Autonomía Robótica

El Paradigma Actual: Los robots actuales son teleoperados; el cirujano toma el 100% de las decisiones.



Nivel 1: Asistencia pasiva
(Visión computacional reconoce órganos/instrumentos).

Nivel 2: Imitation Learning
(El robot aprende observando para replicar tareas repetitivas).

Nivel 3: Ejecución de pasos específicos bajo supervisión humana.

Nivel 4: Autonomía completa
(No es realidad clínica actual por variabilidad anatómica).

Ética y Seguridad: La IA no reemplazará al cirujano, actuará en simbiosis para reducir la variabilidad técnica y aumentar la seguridad.



Síntesis Maestra BADBEAR.MED

Oncología Quirúrgica (Cáncer Gástrico y PEE)

La estadificación dicta la cirugía (Gastrectomía Distal vs Total). **Márgenes R0 y Linfadenectomía D2** son el estándar de oro. **Sospechar PEE (Capullo Abdominal)** en **obstrucciones** de pacientes en **diálisis**.

Fisiopatología Vascular (Várices y Porta)

El GPVH puede engañar en la Enf. Vascular Portosinusoidal (PSVD); la biopsia es vital. Masas inguinales con reflujo en Valsalva obligan a descartar aneurismas safenos antes de operar hernias.

Evolución Tecnológica (Robótica e IA)

La robótica brilla en espacios reducidos (pelvis, mediastino). El futuro no es la máquina operando sola, sino la simbiosis Cirujano-IA para maximizar la seguridad del paciente.



Badbear.med



Badbear.med



Badbear.med



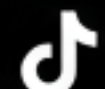
Rutube



OnlyFans



Badbear.med



Badbe

Gemini Notebook